Patientenuntersuchung

XABCDE · SAMPLERS · OPQRST

DATUM _____ SZENARIO / FALL _____ TEAM _____ BEOBACHTER _____

Ersteindruck

- ☐ Eigenschutz, Szene sicher, Anzahl Patienten _____
- ☐ Ersteindruck: kritisch / nicht kritisch _____
- ☐ Nachforderung (NA, weitere Kräfte) erwogen _____

X Exsanguination Kritische Blutung

- ☐ Lebensbedrohliche Blutung gesucht und erkannt
- ☐ Blutung gestoppt (Druck, Druckverband, Tourniquet, Hämostyptikum)
- ☐ Tourniquet-Zeit notiert

A Airway Atemweg und HWS

- ☐ Patient spricht / Atemweg frei
- ☐ Mundraum inspiziert (Fremdkörper, Erbrochenes, Blut, Schwellung)
- ☐ Atemgeräusche (Stridor, Gurgeln, Schnarchen)
- ☐ Atemweg gesichert (Absaugen, Esmarch, Guedel/Wendl, SGA, Intubation)
- ☐ HWS bei Traumamechanismus beachtet / immobilisiert

B Breathing Atmung

- ☐ Atemfrequenz, Atemtiefe, Atemarbeit, Hilfsmuskulatur
- ☐ SpO_2 gemessen
- ☐ Thorax inspiziert (symmetrisch, Prellmarken, paradoxe Atmung)
- ☐ Thorax palpiert (Instabilität, Krepitation, Hautemphysem)
- ☐ Auskultation beidseits, ggf. Perkussion
- ☐ Halsvenen und Trachealage beurteilt
- ☐ $etCO_2$ (falls beatmet / verfügbar)
- ☐ Maßnahmen: O_2, Lagerung, assistierte Beatmung, Entlastung

C Circulation Kreislauf

- ☐ Puls zentral / peripher (Frequenz, Rhythmus, Qualität)
- ☐ Rekapillarisierungszeit
- ☐ Haut: Farbe, Temperatur, Feuchtigkeit
- ☐ Blutungsquellen: Thorax, Abdomen, Becken, Oberschenkel, nach außen
- ☐ Abdomen und Becken beurteilt

D Disability Neurologie

- ☐ Bewusstsein: AVPU / GCS
- ☐ Pupillen: Größe, Form, Lichtreaktion, seitengleich
- ☐ Blutzucker gemessen
- ☐ BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time)
- ☐ Motorik und Sensibilität aller Extremitäten

E Exposure Untersuchung und Umfeld

- ☐ Blutdruck gemessen
- ☐ EKG (3-Kanal, 12-Kanal bei Indikation)
- ☐ Zugang i.v. / i.o., Volumen, Medikamente
- ☐ Entkleidet, Bodycheck von Kopf bis Fuß
- ☐ Rücken untersucht (Log-Roll)
- ☐ Körpertemperatur gemessen
- ☐ Wärmeerhalt sichergestellt
- ☐ Umfeld: Medikamente, Geruch, Hinweise, Unfallmechanismus

Abschluss

- ☐ Verdachtsdiagnose formuliert _____
- ☐ Transportziel und -priorität festgelegt _____
- ☐ Übergabe strukturiert (z. B. SINNHAFT / SBAR) _____
- ☐ Dokumentation vollständig _____

SAMPLERS Anamnese

☐ S	**Symptome**	Hauptproblem, Begleitsymptome
☐ A	**Allergien**	Medikamente, Lebensmittel, Pflaster, Latex
☐ M	**Medikamente**	Dauer- und Bedarfsmedikation, Antikoagulation
☐ P	**Patientengeschichte**	Vorerkrankungen, OPs, Klinikaufenthalte
☐ L	**Letzte ...**	Mahlzeit, Flüssigkeit, Stuhlgang, Miktion, Menstruation
☐ E	**Ereignis**	Was ist passiert? Was wurde zuvor getan?
☐ R	**Risikofaktoren**	Rauchen, Alkohol, Drogen, Diabetes, Hypertonie
☐ S	**Schwangerschaft**	Möglich? Welche Woche? Komplikationen?

OPQRST Schmerz- und Beschwerdeanamnese

☐ O	**Onset**	Beginn: plötzlich oder langsam, wobei?
☐ P	**Provocation / Palliation**	Was verstärkt, was lindert?
☐ Q	**Quality**	Drückend, stechend, brennend, ziehend, kolikartig
☐ R	**Region / Radiation**	Wo genau? Ausstrahlung?
☐ S	**Severity**	Stärke NRS 0–10: _____
☐ T	**Time**	Seit wann? Dauerhaft oder intermittierend? Schon einmal?

Notizen / Debriefing